Körperliche Belastungen in der Hilfe und Pflege zu Hause

Abklären von Hilfsmitteln und Massnahmen

suvapro
Sicher arbeiten

Die vorliegende Broschüre ist eine Entscheidungshilfe für Fachpersonen, die in der Hilfe und Pflege zu Hause tätig sind. Die Anleitung dient bei der Wahl der notwendigen Hilfsmittel und Massnahmen, die zur Vermeidung körperlicher Belastungen eingesetzt werden müssen.

Warum diese Anleitung?

Fachpersonen sind bei der Hilfe und Pflege zu Hause grossen körperlichen Belastungen ausgesetzt. Transport und Umlagerung von Patienten, erzwungene Körperhaltungen, improvisierte Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe (z.B. aufgrund fehlender Pflegebetten) sind eine ständige Gefahr. Dies kann zu Beschwerden am Bewegungsapparat führen, vor allem im Bereich des unteren Rückens. Die Betroffenen sind nicht selten gezwungen, ihre Tätigkeit aufzugeben. Dadurch geht wertvolles Know-how verloren.

Deshalb ist es wichtig,
- **geeignete Hilfsmittel** zur Verfügung zu haben und diese auch einzusetzen
- die **Arbeitsorganisation** den körperlichen Beanspruchungen anzupassen
- mit **körperschonenden Arbeitstechniken** zu arbeiten.

Dadurch können gesundheitliche Beschwerden am Bewegungsapparat vorgebeugt werden.

Wann ist die Anleitung einzusetzen?

Die Situation muss beim Erstbesuch bei der Bedarfsabklärung – in jedem Fall vor dem ersten Einsatz – geprüft werden. Verändert sich die gegebene Situation signifikant, muss diese neu beurteilt werden.

Wie funktioniert die Anleitung?

Die Auswahl und der Einsatz zweckmässiger Hilfsmittel und Massnahmen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Diese Anleitung ist als Leitlinie und Entscheidungshilfe zu verstehen, um den Bedarf an bestimmten Hilfsmitteln und Massnahmen zu ermitteln und mit dem Klienten/der Klientin sowie den Angehörigen zu vereinbaren. Alternative Lösungen wie ein mobiler Patientenlifter oder eine zweite Person[1] sind zulässig, wenn sie einen gleichwertigen Schutz bieten.

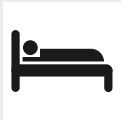
Die Anleitung ist in zwei Schritten aufgebaut:
Schritt 1: Die nachfolgende **Matrix** zeigt die Hilfsmittel und Massnahmen auf, die für die verschiedenen Aktivitäten erforderlich sind. In den meisten Fällen wird dieser erste Schritt genügen.
(Die Beurteilung orientiert sich am RAI-HC, Resident Assessment Instrument Home Care, dem am weitesten verbreiteten Spitex-Bedarfsabklärungsinstrument, setzt dieses aber nicht voraus.)

Schritt 2: Vertiefte Analyse mithilfe eines **Flussdiagramms**. Die erforderlichen Hilfsmittel und Massnahmen werden detaillierter als in Schritt 1 und nachvollziehbar hergeleitet.
Die Diagramme entstammen den «Guidelines for Nursing Homes OSHA», Occupational Safety and Health Administration 3182-3R 2009, und sind leicht modifiziert.

[1] Zweite Person: Pflegefachperson, Angehörige oder nahestehende Bezugspersonen (z.B. Familienmitglied, Nachbar)

Schritt 1

Ermitteln Sie mit der Matrix die erforderlichen Hilfsmittel und Massnahmen. In Klammern ist die entsprechende Kodierung von RAI-HC (Minimum Dataset MSD) angegeben.

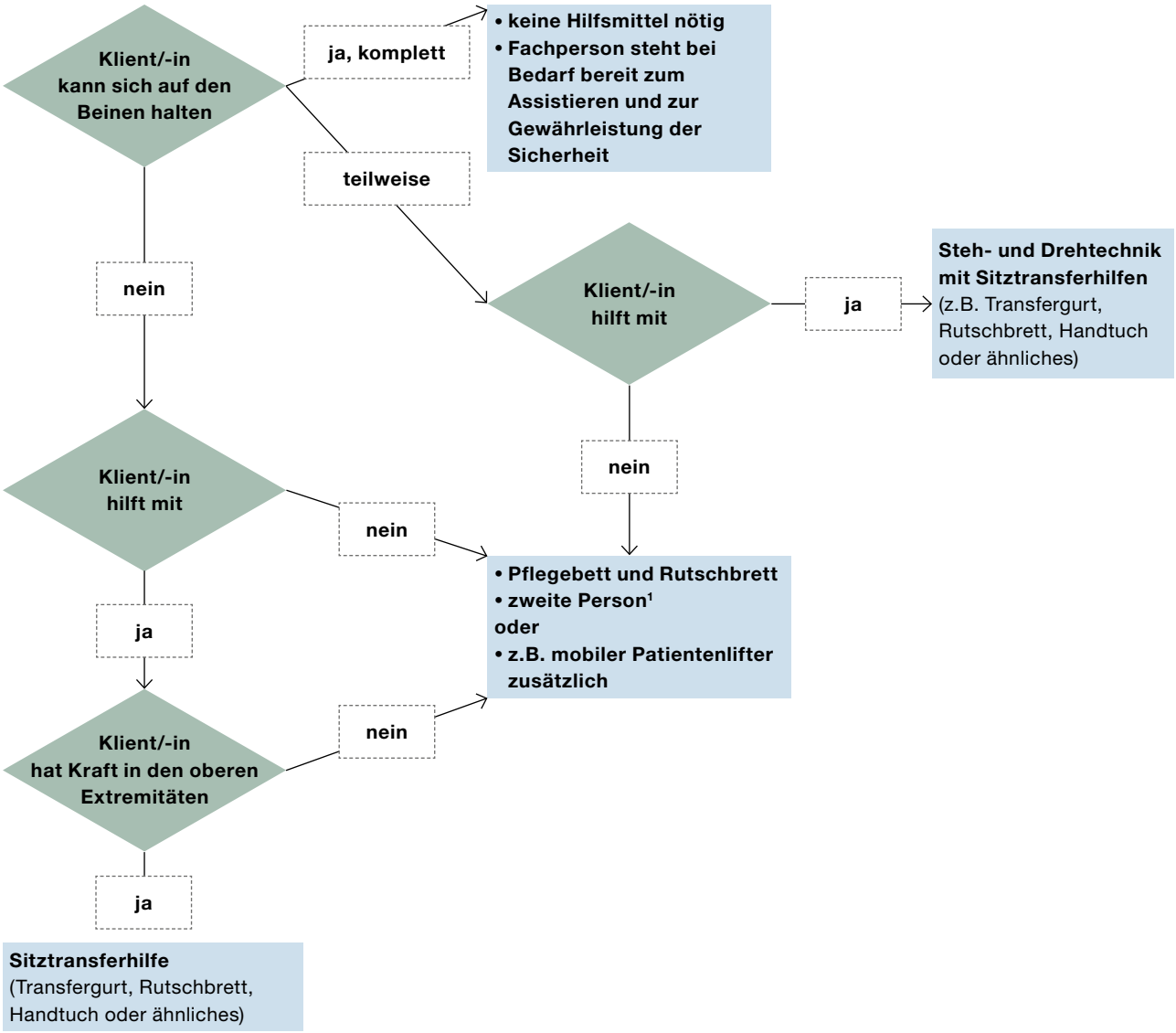
Ausmass der Abhängigkeit / **Aktivität**	**Unabhängig** Klient/-in benötigt keine Hilfe (nur Aufsicht/Überwachung, Anleitung, Ermunterung von der Fachperson)	**Begrenzt** Klient/-in benötigt nur wenig Hilfe, beteiligt sich (Fachperson übernimmt kein Gewicht)	**Verstärkt** Klient/-in benötigt Hilfe, beteiligt sich wenig (Fachperson übernimmt Gewicht)	**Vollständig** Klient/-in benötigt vollständige Hilfe (Fachperson übernimmt Aktivitäten)
Mobilisierung zwischen Bett/ Stuhl oder in aufrechte Position (z.B. Aufrichten in Pflegestuhl, zwischen Rollstuhl/WC)	-	-	• Pflegebett (beidseitig zugänglich) • Transferhilfsmittel (RAI-HC H2a 3)	• Pflegebett (beidseitig zugänglich) • zweite Person[1] • Transferhilfsmittel (RAI-HC H2b 4)
 **Mobilisierung im Bett**	-	• Pflegebett (beidseitig zugänglich) (RAI-HC H2a 2)	• Pflegebett (beidseitig zugänglich) (RAI-HC H2a 3)	• Pflegebett (beidseitig zugänglich) • zweite Person[1] • Transferhilfsmittel (RAI-C H2a 4)
Baden (inkl. Duschen/ Ganzkörperwäsche)	Hilfsmittel prüfen wie rutschsicherer Teppich, Badewannenbrett, Duschmatte (RAI-HC H2j 1-4)			
	-	-	-	• zweite Person[1] (wenn Klient/-in > 80 kg) (RAI-HC H2j 4)

[1] Zweite Person: Pflegefachperson, Angehörige oder nahestehende Bezugspersonen (z.B. Familienmitglied, Nachbar)

Schritt 2

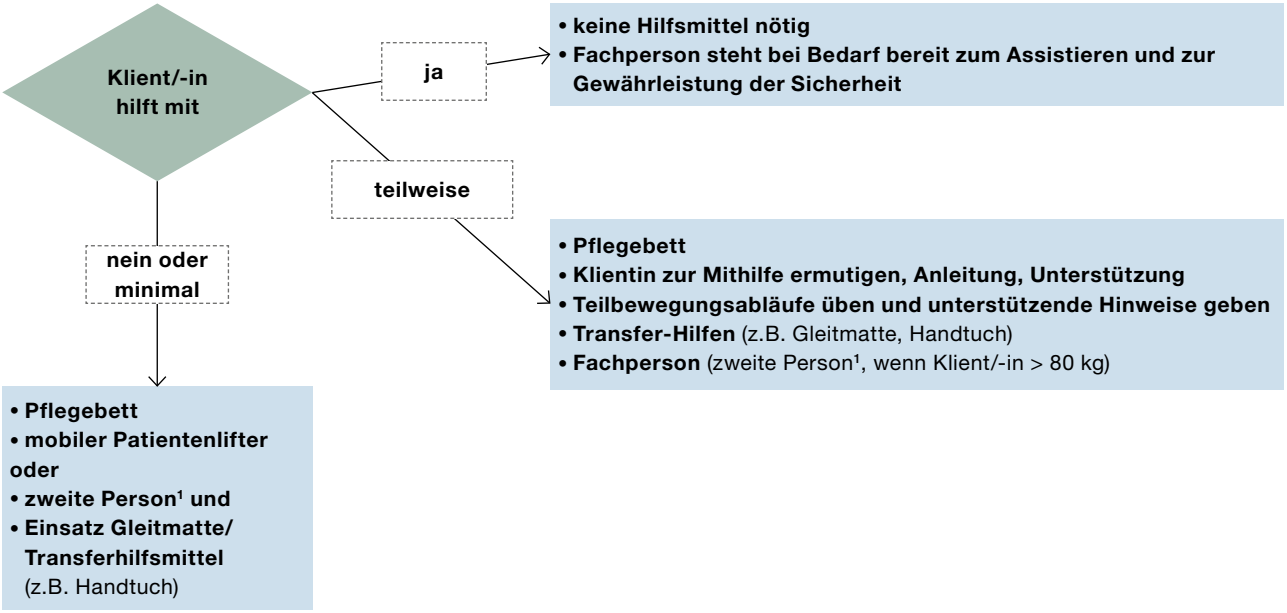
Vertiefte Analyse mithilfe von Flussdiagrammen.

Mobilisierung zwischen Bett/Stuhl oder in aufrechte Position
(z.B. Aufrichten in Pflegestuhl, zwischen Rollstuhl/WC)

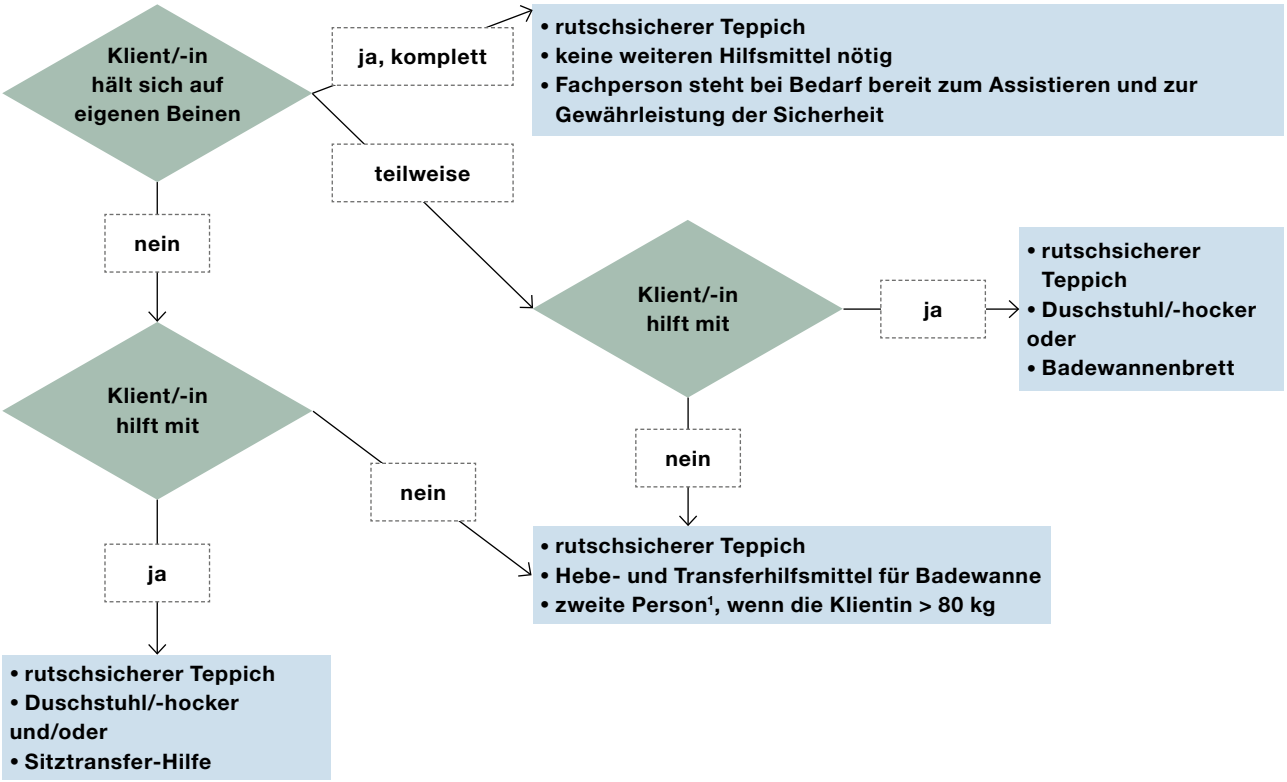


¹ Zweite Person: Pflegefachperson, Angehörige oder nahestehende Bezugspersonen (z.B. Familienmitglied, Nachbar)

Mobilisierung im Bett



Baden (inkl. Duschen/Ganzkörperwäsche)



¹ Zweite Person: Pflegefachperson, Angehörige oder nahestehende Bezugspersonen (z.B. Familienmitglied, Nachbar)

Was es weiter zu beachten gilt

Arbeitstechniken vs. Hilfsmittel

In der Hilfe und Pflege zu Hause soll den Klientinnen und Klienten nur abgenommen werden, was sie selbst nicht mehr zu leisten vermögen. Die aktive Nutzung der noch vorhandenen Ressourcen erleichtert den Fachpersonen die Arbeit, erhält oder verbessert aber auch die Leistungsfähigkeit der gepflegten und betreuten Personen.

Eine körperschonende Arbeitstechnik wie z.B. die Kinästhetik – eine spezielle Lehre und Methode der Bewegungswahrnehmung – kann in gewissen Fällen als Alternative zum Einsatz von Hilfsmitteln gelten, sofern eine anerkannte Ausbildung absolviert wurde.

Bauliche Gegebenheiten

Auf die baulichen Gegebenheiten und Einrichtungen wird in dieser Anleitung nicht vertieft eingegangen. Oft können die Hilfsmittel an besondere bauliche Gegebenheiten angepasst werden (z.B. weniger breiter Rollstuhl). Es können auch ungünstige bauliche Gegebenheiten beseitigt werden: z.B. Türschwellen mit einem keilförmigen Absatz behindertengerecht oder rollstuhlgängig gestalten oder Pflegebett beidseitig zugänglich machen.

Offizielle Vereinbarung

Wir empfehlen Ihnen, einen Vertrag oder eine schriftliche Vereinbarung zwischen Ihrer Organisation und der Klientin/dem Klienten abzuschliessen. Bei den verschiedenen kantonalen Spitex-Verbänden können Musterverträge oder -vereinbarungen heruntergeladen bzw. bestellt werden.

Unfallprävention in der Pflege zu Hause

Lesen Sie ausführliche Informationen zum Thema in der EKAS-Broschüre «Unfall – kein Zufall! Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex)», EKAS-Bestellnummer 6291.d.

Die Suva dankt den folgenden Fachleuten für die Mitwirkung an dieser Broschüre:
Association Spitex privée Suisse ASPS, Suzanne Scherrer
Permed AG, Nora Fischer
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK, Elvira Nussbaumer
Scudo Lugano, Fabienne Cocchi, Rosaria Salbonier
Spitex Aarwangen, Hanni Kröplin
Spitex Binningen, Silvana Schneider
Spitex Verband Kanton Aargau, Max Moor
Spitex Verband Schweiz, Silvia Marti
Spitex Zürich Limmat AG, Christine Reichart
Spitex Zürich Sihl, Peter Eckert

Suva
Postfach, 6002 Luzern

Auskünfte
Tel. 041 419 58 51

Bestellungen
www.suva.ch/waswo
Fax 041 419 59 17
Tel. 041 419 58 51

Titel
Hilfsmittel und Massnahmen in der Hilfe und Pflege zu Hause
Anleitung für die Bedarfsabklärung

Verfasser
Suva, Bereich Physik, Team Ergonomie

Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung – mit Quellenangabe gestattet.
Erstausgabe: Juni 2015

Bestellnummer
66132.d

Das Modell Suva
Die vier Grundpfeiler der Suva

- Die Suva ist mehr als eine Versicherung; sie vereint Prävention, Versicherung und Rehabilitation.
- Die Suva wird von den Sozialpartnern geführt. Die ausgewogene Zusammensetzung im Verwaltungsrat aus Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Bundesvertretern ermöglicht breit abgestützte, tragfähige Lösungen.
- Gewinne gibt die Suva in Form von tieferen Prämien an die Versicherten zurück.
- Die Suva ist selbsttragend; sie erhält keine öffentlichen Gelder.